DỊCH TỄ HỌC CÁC BỆNH UNG THƯ

HOÀNG THỊ HẢI VÂN
BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC
0942248959
hoangthihaivan@hmu.edu.vn

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về các bệnh ung thư
2. Trình bày được phân bố và tỷ lệ các bệnh ung thư hiện nay trên thế giới và Việt Nam
3. Liệt kê được các yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư
4. Trình bày được phương pháp giám sát ung thư và các chiến lược dự phòng ung thư

UNG THƯ LÀ GÌ?

Ung thư là thuật ngữ gốc nói tới các nhóm bệnh mà có thể ảnh hưởng tới bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Các thuật ngữ khác được sử dụng bao gồm u ác tính hoặc khối u. Đặc điểm của ung thư là sự tăng sinh nhanh các tế bào bất thường vượt ra ngoài vùng sinh sống bình thường của chúng và các tế bào này có thể xâm nhập vào các khu vực lân cận của cơ thể và lan tỏa ra các cơ quan nội tạng khác, hay còn gọi là di căn. Di căn là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư (WHO).

UNG THƯ LÀ GÌ?

- Khối u (neoplasm) hay khối tân sản là danh từ chỉ khối tế bào mới, hình thành do rối loạn sự tăng sản quá mức tế bào (hyperplasia) từ một dòng đã trở thành bất thường, sự tăng sản này không có mối tương quan nào với yêu cầu của cơ thể, khối u có thể tiến triển lành tính hoặc ác tính (Tổ chức chống UT quốc tế (UICC))

UNG THƯ LÀ GÌ?

- "Ung thư hay còn gọi là u ác tính, là một nhóm các bệnh liên quan đến phân chia tế bào một cách vô tổ chức, không chịu sự kiểm soát của cơ chế điều khiển bình thường của cơ thể; các tế bào này có khả năng xâm lấn những mô khỏe bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di chuyển đến nơi xa (di căn)".

UNG THƯ LÀ GÌ?

- Ung thư là bệnh ác tính của tế bào, là sự rối loạn phát triển các tế bào trong cơ thể. Khi có đột biến xảy ra trong ADN, cơ chế chết theo chương trình của tế bào bị phá vỡ, có thể dẫn đến UT. Một tập hợp các tế bào UT gọi là khối u tiếp tục phát triển, tốc độ phân bào gia tăng, mất tính biệt hoá tế bào, không còn tính chất ức chế tiếp xúc, xâm lấn vào các tổ chức lành xung quanh, di căn đến các hạch bạch huyết hoặc các tạng khác của cơ thể.

UNG THƯ LÀ GÌ?

- Các khối u được chia làm 2 loại: lành tính và ác tính;
- U lành tính (nốt ruồi, hột cơm, các u nang...) phát triển tại chỗ, không lan tràn đến nơi khác trong cơ thể hay xâm lấn vào các mô khác, ít khi đe dọa đến tính mạng trừ khi chúng chèn ép đến các cấu trúc sống còn.
- U ác tính phát triển thường kèm theo sự xâm nhập. Chúng thường không có giới hạn rõ với mô bình thường xung quanh.
- Hầu hết các u lành tính phát triển chậm qua thời gian hàng năm, trong khi hầu hết các u UT phát triển nhanh.

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ

- Tỷ lệ mới mắc
- Tỷ lệ mắc bệnh toàn bộ
- Tỷ lệ tử vong
- Tần suất sống thêm
- Ghi nhận ung thư

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ – TỶ LỆ MỚI MẮC

- Tỷ lệ mới mắc là số ca mới mắc trong quần thể/100.000 dân/năm (theo vị trí, nhiều vị trí).
- Ví dụ: số ca mới mắc toàn thế giới (1980): 6,4 triệu; 1985: 7,6 triệu; 2000: 10 triệu; 2018:18,1 triệu
- Tỷ lệ mắc theo từng loại UT hoặc tất cả các loại UT; theo chủng tộc, giới tính, theo lứa tuổi...

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ – TỶ LỆ MỚI MẮC

Ý nghĩa của tỷ lệ mới mắc:

+ Cung cấp dữ liệu về sự xuất hiện UT, mô tả gánh nặng đối với xã hội.

+ Biết được mô hình bệnh UT.

+ Xu hướng mắc bệnh (tăng, giảm, loại nào tăng, loại nào giảm...).

+ Cơ sở để hoạch định chính sách trong tương lai phòng chống UT.

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ – TỶ LỆ MỚI MẮC

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mới mắc:

+ Tuổi: yếu tố quan trọng nhất xác định nguy cơ, tăng theo thời gian.

+ Giới tính: liên quan tiếp xúc tác nhân sinh UT.

+ Địa lý: khác biệt rõ rệt giữa các vùng.

+ Dân tộc: khác nhau do di truyền, lối sống.

+ Tôn giáo, hoàn cảnh xã hội.

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ – TỶ LỆ MẮC BỆNH TOÀN BỘ

- Tỷ lệ mắc bệnh toàn bộ: là số ước tính người mắc UT trong thời một điểm nhất định hoặc trong khoảng thời gian nhất định.
- Tỷ lệ mắc bệnh toàn bộ của từng loại bệnh UT hay của tất cả các bệnh UT cộng lại. Tính trên 100.000 dân hoặc tỷ lệ số ca theo thống kê bệnh viện.
- Ý nghĩa của tỷ lệ mắc bệnh toàn bộ:

+ Mô tả gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng.

+ Tỷ lệ mắc bộ toàn bộ phụ thuộc tỷ lệ mới mắc và thời gian sống thêm trung bình. Thời gian sống thêm trung bình càng dài thì tỷ lệ mắc bệnh toàn bộ sẽ tăng cho dù tỷ lệ mới mắc có thể không tăng.

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ – TỶ LỆ TỬ VONG

- Tỷ lệ tử vong: Tỷ lệ tử vong là số ca tử vong do UT /100.000 dân/năm, phản ánh cho toàn bộ dân cư hoặc cho từng giới, từng lứa tuổi.
- Tỷ lệ tử vong phụ thuộc vào cấu trúc tuổi, biện pháp chẩn đoán.

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ – TẦN SUẤT SỐNG THÊM

- Tần suất sống thêm: là tỷ lệ bệnh nhân còn sống sau một quãng thời gian theo dõi.
- Trung vị thời gian sống thêm là quãng thời gian có 50% bệnh nhân theo dõi chết. Trung vị có giá trị hơn thời gian sống thêm trung bình vì thời gian sống thêm biến động quá rộng.
- Thời gian hết bệnh (disease free) là khoảng thời gian từ khi bệnh nhân hết các triệu chứng lâm sàng của bệnh đến khi có tái phát.

CÁC ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ – GHI NHẬN UNG THƯ

- Ghi nhận UT là quá trình thu thập một cách có hệ thống và liên tục số liệu về tình hình mắc bệnh cũng như đặc điểm các loại UT ghi nhận được nhằm giúp cho việc đánh giá và kiểm soát gánh nặng UT trong cộng đồng.
- Có thể ghi nhận UT trong bệnh viện bằng cách thống kê các trường hợp UT được điều trị với mục đích ghi nhận cơ cấu hiện trạng các loại bệnh UT được chẩn đoán, điều trị tại bệnh viện.
- Có thể ghi nhận UT quần thể bằng cách thống kê tất cả các bệnh nhân UT xuất hiện trong một quần thể xác định và trong một khoảng thời gian xác định với mục đích chính là xác định tỷ lệ mắc bệnh trong quần thể đó.

GÁNH NẶNG UNG THƯ

- Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, gây ra khoảng 8,8 triệu ca tử vong năm 2015; 9,6 triệu ca tử vong năm 2018
- Ung thư phổ biến nhất gây tử vong là:
  - Ung thư phổi (1,69 triệu ca tử vong)
  - Ung thư gan (788 000 ca tử vong)
  - Ung thư đại trực tràng (774 000 ca tử vong)
  - Ung thư dạ dày (754 000 ca tử vong)
  - Ung thư vú (571 000 ca tử vong)

NGUYÊN NHÂN GÂY UNG THƯ

Ung thư là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố gen của một người và 3 nhóm yếu tố bên ngoài, bao gồm:

- Các yếu tố vật lý gây ung thư như bức xạ tia cực tím và ion hóa;
- Các chất hóa học gây ung thư như a-mi-ăng, các thành phần của khói thuốc lá, aflatoxin (chất gây ô nhiễm thức ăn), và a-xen (chất gây ô nhiễm nước sinh hoạt); và
- Các chất gây ung thư sinh học như một số virút, vi khuẩn hoặc kí sinh trùng nào đó.

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY UNG THƯ

- Hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn uống không hợp lý và ít hoạt động thể lực là những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư trên thế giới

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY UNG THƯ

- Một số tình trạng viêm mạn tính cũng là yếu tố nguy cơ gây ung thư và khá phổ biến ở các nước thu nhập thấp và trung bình.
  - Khoảng 15% ung thư được chẩn đoán năm 2012 là do nguyên nhân viêm nhiễm, bao gồm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori- gây viêm loét dạ dày), vi-rút HPV (Human papillomavirus, gây viêm cổ tử cung), vi-rút viêm gan B, vi-rút viêm gan C và vi-rút Epstein-Barr*(3)*.
  - Vi-rút viêm gan B và C và một số loại HPV làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan và ung thư cổ tử cung. Nhiễm HIV cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư như là ung thư cổ tử cung.

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY UNG THƯ

- Chấn thương
- Chấn thương tâm lý
- Thói quen sống: ví dụ phơi nắng

DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ TRÊN THẾ GIỚI

International Agency for Research on Cancer

World Health Organization

PRESS RELEASE
N° 263

12 September 2018

Latest global cancer data:
Cancer burden rises to 18.1 million new cases and 9.6 million cancer deaths in 2018

Strictly embargoed until Wednesday 12 September 2018, 16h00pm Geneva time

DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ TRÊN THẾ GIỚI

- Ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên thế giới với khoảng 14 triệu ca mới mắc hàng năm – theo số liệu của năm 2012*(1)*.
- Số ca mới mắc dự báo sẽ tăng khoảng 70% trong vòng 2 thập kỷ tới.
- Ung thư là nguyên nhân thứ hai gây tử vong trên toàn cầu, với 8,8 triệu ca tử vong năm 2015. Trên thế giới, gần 1/6 ca tử vong là do ung thư.
- Khoảng 70% số trường hợp tử vong do ung thư là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ TRÊN THẾ GIỚI

- Khoảng một phần ba số ca tử vong do ung thư là do 5 yếu tố nguy cơ về hành vi và chế độ ăn: chỉ số khối cơ thể cao (thừa cân-béo phì), chế độ ăn ít trái cây và rau xanh, ít vận động thể lực, hút thuốc lá và uống rượu.
- Hút thuốc là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây ung thư, chiếm khoảng 22% số ca tử vong do căn bệnh này.*(2)*
- Viêm nhiễm mạn tính gây ung thư như viêm gan, viêm cổ tử cung do HPV (một trong những vi-rút lây nhiễm qua đường tình dục) gây ra khoảng 25% các ca mắc ung thư ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.*(3)*

DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ TRÊN THẾ GIỚI

- Đến khám muộn và không được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán và điều trị là rất phổ biến. Năm 2015, chỉ 35% các nước thu nhập thấp cho biết là có dịch vụ giải phẫu bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Hơn 90% nước thu nhập cao có dịch vụ điều trị ung thư trong khi đó tỷ lệ này ở các nước có thu nhập thấp chỉ chưa tới 30%.
- Tác động kinh tế của ung thư rất lớn và ngày càng tăng. Tổng chi phí kinh tế hàng năm do ung thư năm 2010 ước tính xấp xỉ 1,16 nghìn tỉ đô-la.*(4)*
- Chỉ có 1/5 các nước có thu nhập thấp và trung bình có số liệu cần thiết cho xây dựng chính sách về phòng chống ung thư.*(5)*

DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ TẠI VIỆT NAM

- Ung thư là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở Việt Nam với khoảng 95.000 ca tử vong mỗi năm
- Hàng năm có khoảng 125.000 trường hợp mới mắc ung thư
- Ung thư phổ biến nhất ở nam giới là ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư vòm họng.

DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ TẠI VIỆT NAM

- Ung thư phổ biến nhất ở nữ giới là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư cổ tử cung và ung thư dạ dày.
- Khoảng 71,4% trường hợp ung thư tới bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn.
- Một số yếu tố nguy cơ gây ung thư liên quan đến hành vi và chế độ ăn bao gồm thói quen hút thuốc lá ở nam giới (45,3%), uống rượu bia ở nam giới (77.3%), chế độ ăn ít rau và trái cây (57.2%), và thiếu hoạt động thể lực (28.1%)

DỰ PHÒNG UNG THƯ

- Khoảng 30–50% ung thư có thể phòng ngừa được.
- Có thể phòng ngừa được ung thư bằng cách:
  - Kiểm soát các yếu tố nguy cơ
  - triển khai các chiến lược phòng chống ung thư dựa trên bằng chứng hiện có.
  - Phát hiện sớm và quản lý điều trị bệnh nhân.
- Nhiều loại ung thư có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đầy đủ.

DỰ PHÒNG UNG THƯ – kiểm soát các yếu tố nguy cơ

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể giảm mạnh gánh nặnh ung thư. Các yếu tố nguy cơ này gồm:

- Hút thuốc lá bao gồm thuốc lá điếu và thuốc lá không khói
- Thừa cân hoặc béo phì
- Chế độ ăn không lành mạnh, ít trái cây và rau xanh
- Thiếu hoạt động thể lực
- Uống rượu bia

DỰ PHÒNG UNG THƯ – kiểm soát các yếu tố nguy cơ

- Nhiễm HPV (vi rút gây viêm cổ tử cung)
- Viêm gan hoặc các viêm nhiễm sinh ung thư khác
- Bức xạ -ion hóa và tia cực tím
- Ô nhiễm không khí đô thị
- Khói trong nhà từ hộ gia đình sử dụng chất đốt rắn.
- Hút thuốc là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây ung thư và gây ra khoảng 22% ca tử vong do ung thư trên toàn cầu.

DỰ PHÒNG UNG THƯ – triển khai các chiến lược dự phòng

- Tránh các yếu tố nguy cơ như nêu ở trên;
- Tiêm vắc-xin phòng HPV và vi-rút viêm gan B;
- Kiểm soát các yếu tố nguy hại nghề nghiệp;
- Giảm tiếp xúc bức xạ tia cực tím;
- Giảm tiếp xúc bức xạ i-on hóa (nghề nghiệp hoặc chẩn đoán hình ảnh trong y tế).
- Tiêm vắc-xin phòng HPV và viêm gan B có thể phòng tránh được 1 triệu ca ung thư mỗi năm

DỰ PHÒNG UNG THƯ – phát hiện sớm

- Chẩn đoán sớm
- Sàng lọc

DỰ PHÒNG UNG THƯ – phát hiện sớm

- Chẩn đoán sớm:
  - Tăng nhận thức và tiếp cận chăm sóc
  - Chẩn đoán và xác định giai đoạn bệnh
  - Tiếp cận điều trị

DỰ PHÒNG UNG THƯ – phát hiện sớm

- Sàng lọc: Sàng lọc nhằm mục đích phát hiện những người có các dấu hiệu bất thường, gợi ý mắc một loại ung thư hoặc tiền ung thư nào đó – tức là vẫn chưa phát triển thành ung thư và triệu chứng ung thư, rồi sớm chuyển họ tới cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị.
- Các chương trình sàng lọc có thể hiệu quả với một số loại ung thư khi các xét nghiệm phù hợp được sử dụng, có kết nối tới các bước khác trong quá trình sàng lọc và chất lượng được đảm bảo. Nói chung, chương trình sàng lọc là một can thiệp y tế công cộng phức tạp hơn nhiều so với chẩn đoán sớm.

DỰ PHÒNG UNG THƯ – phát hiện sớm

Ví dụ về các phương pháp sàng lọc ung thư:

- Quan sát cổ tử cung bằng mắt thường với nhuộm cổ tử cung bằng dung dịch axit acetic (VIA) để phát hiện ung thư cổ tử cung ở các nước có thu nhập thấp;
- Xét nghiệm HPV nhằm phát hiện ung thư cổ tử cung;
- Soi cổ tử cung (PAP) nhằm phát hiện ung thư cổ tử cung ở các nước có thu nhập trung bình và cao; và
- Sàng lọc ung thư vú bằng chụp tuyến vú (mammography) ở các nước có hệ thống y tế tốt hoặc tương đối tốt.

GIẢM GÁNH NẶNG UNG THƯ – ĐIỀU TRỊ

- Mục đích điều trị: Điều trị khỏi ung thư hoặc kéo dài cuộc sống cho người bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh
- **Khả năng điều trị khỏi những trường hợp được phát hiện sớm**
- **Khả năng điều trị khỏi cho một số loại ung thư**
- **Chăm sóc giảm nhẹ**

GIẢM GÁNH NẶNG UNG THƯ – CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

- Chăm sóc giảm nhẹ là điều trị để làm giảm các triệu chứng gây ra bởi ung thư – chứ không phải là điều trị khỏi – và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình họ.
- Chăm sóc giảm nhẹ có thể giúp người bệnh sống thoải mái hơn.
- Có thể giúp giảm nhẹ đau đớn về thể xác, tâm sinh lý và tinh thần ở trên 90% bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn thông qua chăm sóc giảm nhẹ.

GIẢM GÁNH NẶNG UNG THƯ – CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

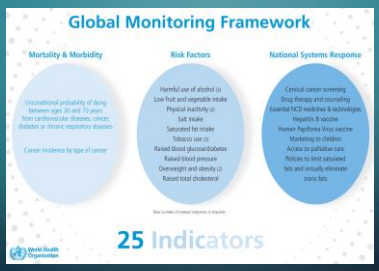
Các chiến lược chăm sóc giảm nhẹ

- Các chiến lược y tế công cộng hiệu quả gồm chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng là rất cần thiết hỗ trợ kiểm soát đau và chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh, gia đình người bệnh tại các khu vực nguồn lực hạn chế.
- Cải thiện tiếp cận với thuốc giảm đau morphine đường uống trong điều trị các trường hợp đau do ung thư mức độ từ vừa phải tới trầm trọng mà có đến trên 80% bệnh nhân giai đoạn cuối gặp phải là bắt buộc.

HÀNH ĐỘNG CỦA WHO TRONG PHÒNG CHỐNG UNG THƯ

- Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới phát động động Kế hoạch hành động Toàn cầu về Phòng chống các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2013-2020 nhằm mục tiêu giảm 25% số ca tử vong sớm do ung thư, các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường và các bệnh hô hấp mạn tính vào năm 2025.

- Kế hoạch Hành động Toàn cầu về phòng chống các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2013-2020



HÀNH ĐỘNG CỦA WHO TRONG PHÒNG CHỐNG UNG THƯ

- Đẩy mạnh cam kết chính trị cho phòng chống ung thư;
- Phối hợp và tiến hành nghiên cứu nguyên nhân gây ung thư ở người và cơ chế sinh ung thư;
- Theo dõi gánh nặng ung thư (là một phần trong sáng kiến toàn cầu về hệ thống ghi nhận ung thư);
- Xác định các chiến lược ưu tiên về phòng chống ung thư;
- Xây dựng các tiêu chuẩn và công cụ hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai can thiệp phòng chống, chẩn đoán sớm, sàng lọc, điều trị chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ kéo dài sự sống cho người bệnh;

HÀNH ĐỘNG CỦA WHO TRONG PHÒNG CHỐNG UNG THƯ

- Hỗ trợ mở rộng mạng lưới phòng chống ung thư với các đối tác và các chuyên gia ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia;
- Củng cố hệ thống y tế ở cấp độ quốc gia và địa phương nhằm hỗ trợ điều trị và chăm sóc cho người bệnh;
- Thực hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu cũng như hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho Chính phủ các nước và các đối tác để xây dựng và duy trì các chương trình phòng chống ung thư cổ tử cung chất lượng cao;
- Hỗ trợ kĩ thuật trong việc chuyển giao nhanh và hiệu quả các can thiệp tốt nhất cho các nước kém phát triển.

HOẠT ĐỘNG PHÒNG UNG THƯ TẠI VIỆT NAM

- Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm 2015-2020
- Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

HOẠT ĐỘNG PHÒNG UNG THƯ TẠI VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- http://www.apps.who.int/iris/bitstream/10665/94554/1/9789241506236_eng.pdf
- http://benhviem.com.vn/Kiu-Kuanh-chung-ung-cho-chuyen-gia-vi-01777.html
- https://f5g.org.vn/y-te-sinh-san-da-lac-hien-suat-phi-Ra-Sinh-Sang
- Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020
- https://www.who.int/cancer/PEN/Outbreak/Final.pdf
- https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type
- Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020
- Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm 2015-2020